

Obstrução intestinal · diagnóstico e conduta

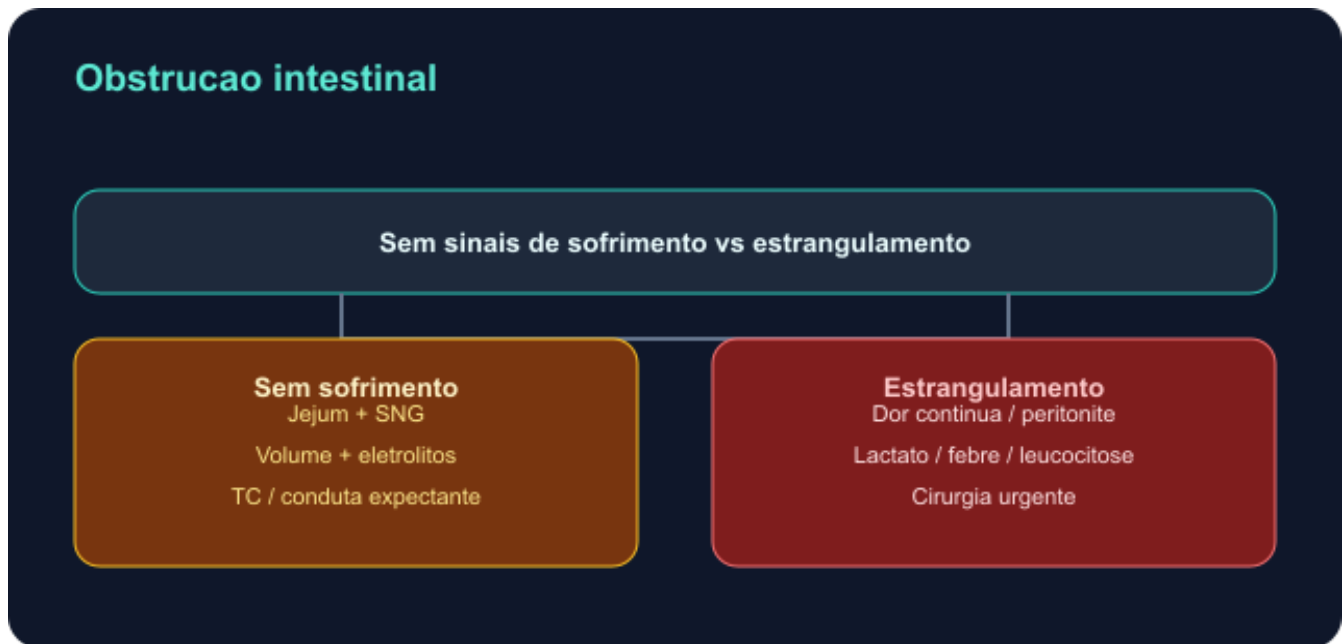
Obstrução = parada ou lentificação do trânsito com dor, distensão, vômitos e parada de eliminação. Diferencie mecânica de íleo parálítico e procure sinais de isquemia/estrangulamento.

Causas clássicas

Lembre - Causas clássicas

Delgado: bridas/aderências, hérnias, tumores. Cólon: câncer, volvo, diverticulite. Íleo: pós-op, eletrólitos, fármacos, sepse abdominal.

Ramificação: estável sem peritonite !' reanimação + sonda + TC; sofrimento/peritonite !' cirurgia.



Avaliação

- Exame: cicatrizes, hérnias, ruídos metálicos vs silêncio, peritonite
- Lab: leucócitos, lactato, eletrólitos, função renal
- Rx: níveis hidroaéreos; TC com contraste define transição e complicações
- Reanimação: volume, correção de K z/Mg² z, descompressão com SNG

Sinais de estrangulamento

Achado | Conduta

Dor contínua + defesa | Cirurgia sem demora
Febre / taquicardia / leucocitose | Suspeitar isquemia
Lactato elevado / acidose | Sala + reanimação
Pneumoperitônio | Perfuração — laparotomia

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Íleo parálítico não se opera 'por imagem de dilatação' isolada — trate causa. Já a obstrução mecânica com sinais de sofrimento intestinal não fica só na sonda nasogástrica.

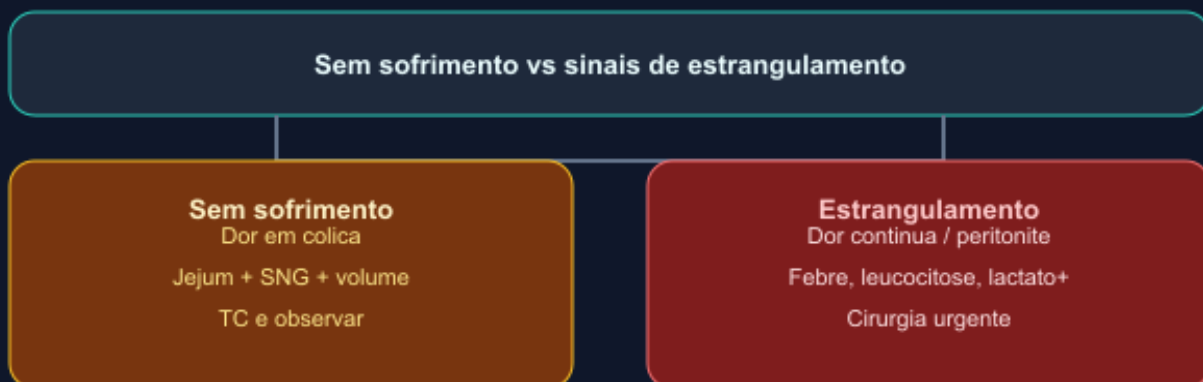
Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Obstrução intestinal: diferenciar mecânica de íleo e, sobretudo, detectar estrangulamento — indicação cirúrgica urgente.

Ramificação clássica: estável sem peritonite !' reanimação + SNG + imagem; estrangulamento !' cirurgia urgente.

Obstrução intestinal



Sinais de estrangulamento (não omitir)

- Dor contínua e progressiva (deixa de ser cólica)
- Sinais peritoneais / defesa
- Febre, taquicardia, toxemia
- Leucocitose importante, acidose, lactato!'
- TC: pneumatose, gás portal, falta de realce parietal, líquido/perfurado

Delgado vs cólon (ideia)

| Delgado | Cólon

Causas | Bidas, hérnia, tumor | Câncer, volvo, diverticulite

Vômitos | Precoces | Mais tardios

Distensão | Central | Periférica / assimétrica

Conduta inicial

Lembre - Conduta inicial

Nada VO, sonda nasogástrica, volume e eletrólitos, ATB se suspeita de sofrimento/perfuração. Cirurgia se estrangulamento, peritonite, hernia encarcerada irreductível ou falha do tratamento conservador.

Íleo adinâmico

Dica - Íleo adinâmico

Pós-op, eletrólitos, fármacos, sepse — ruídos diminuídos, menos cólica; trate a causa, não 'desobstrua' às cegas.